

РАК ЛЕГКОГО

УДК: 616.24-006.6-073.75

^{1,2}Ж.Ж. Жолдыбай, ^{1,2}Ж.К. Жакенова, ¹А.К. Кокталов, ¹Д.И. Сематов, ¹Ж.А. Калыев, ¹Г.С. Ахметова¹Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии,²Казахский Национальный Медицинский Университет им. С.Д. Асфендиярова**Возможности компьютерной томографии в ранней диагностике рака легких**

Аннотация. В работе описаны возможности компьютерной томографии в ранней диагностике рака легких. Всего было обследовано 3089 пациента с заболеваниями легких, из них анализ проведен 190 пациентам с впервые выявленным раком легких по полу, возрасту, типу роста, локализации процесса. Представлена краткая характеристика и лучевая семиотика рака легких. Работа сопровождается иллюстративным материалом.

Ключевые слова: компьютерная томография, рак, легкие.

Актуальность. Рак легкого (РЛ) – наиболее распространенное в мировой практике злокачественное новообразование. С начала XX века заболеваемость РЛ выросла в несколько десятков раз, и особенно выражен ее рост в индустриально развитых странах, где в структуре онкопатологии РЛ занимает первое место[1-2]. Компьютерная томография дает возможность выявить морфологические характеристики и, таким образом, выставить правильные диагнозы визуализации рака легких [3-6].

Рак легкого занимает первое место по смертности среди пациентов с онкозаболеваниями в Казахстане. Во всем мире в 2012 году было диагностировано 1,6 миллиона новых случаев рака легких [1].

Компьютерная томография – «золотой стандарт» для дополнительного обследования легких: высокая информативность при исследовании; возможность полипозиционного изображения органа; возможность визуализации не пальпируемых образований; возможность дифференциальной диагностики узловых и диффузных заболеваний; возможность оценить степень распространенности процесса.

Компьютерная томография является доступным и относительно недорогим методом и играет важную роль в раннем выявлении рака легких.

Материал и методы исследования: С 1 января 2015г по 10 ноября 2016г 3089 пациентам проведена компьютерная томография легких в КазНИИОиР, из них у 190 (6%) пациентов был выявлен впервые выявленный рак легких.

Исследования проведены на КТ аппарате Light Speed VCT (GE) по стандартной методике и согласно протоколу.

Средний возраст пациентов с раком легких составил 62,6 лет.

Результаты: Проведенный анализ результатов выявил следующее распределение пациентов по полу, что рак легкого

чаще встречается у мужчин (77,4%) в сравнении с женщинами (22,6%).



Рисунок 1 – Распределение по полу

На рисунке 1 представлены данные, что РЛ в 3,4 раза чаще встречается у мужчин.

При выведении возрастных категории у лиц с новообразованием, выявлено, что основное количество рака легких встречается в возрасте от 50 до 69 лет.

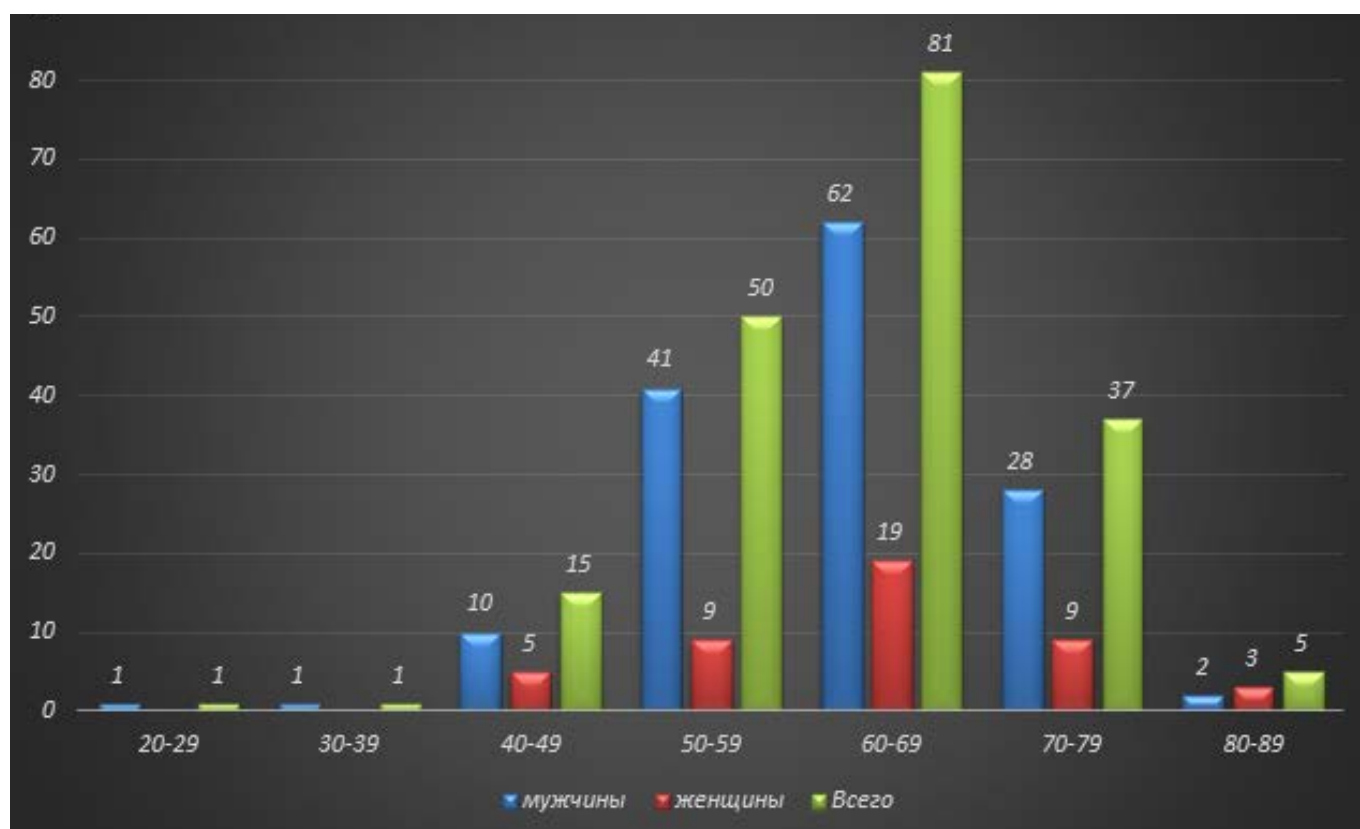


Рисунок 2 – Распределение по возрасту

На рисунке 2 видно, что наибольшая заболеваемость РЛ отмечается в возрастной группе 60-69 лет и составляет 42,6%, меньше идет категория 50-59 лет (26,3), третье место занимает группа пациентов в возрасте 70-79 лет (19,4). Далее все оставшиеся возрастные группы идут по убыванию 40-49 лет, 80-89 лет, в группах 30-39 и 20-29 по 1 пациенту.

Также нами проведен анализ результатов КТ РЛ по типу роста, было выявлено преобладание центрального рака, что составило 60,5%, над периферическим – 39,5%.



Рисунок 3 – Распределение по форме роста

Как показано на рисунке 3 по данным нашего анализа распределение по форме роста РЛ, центральный рак составил 115 случаев (60,5%) из 190 пациентов, а периферический – 75 случаев (39,5%).

Далее мы провели анализ распределения пациентов с РЛ по локализации процесса в левом легком (52,6%), в правом (47,4%)

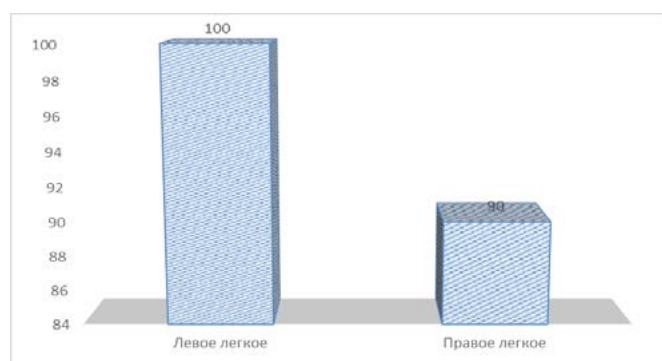


Рисунок 4 – Локализация процесса

На рисунке 4 указана локализация процесса, из чего следует небольшое преобладание количества РЛ в левом легком – 100 случаев, над правым легким – 90 случаев.

Вывод. Методом первой очереди при выявлении рака легких по-прежнему является РГ, но она должна обязательно дополняться компьютерной томографией, которая является неотъемлемым методом выбора в диагностике и оценке распространенности рака легких.

Список литературы

1. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Злокачественные новообразования в России и странах СНГ.-М., 2003.
2. Трахтенберг А.Х., Колбанов К.И. Рак легкого. –М.,2008;
3. Murata K., Khan A., Herman P.G. Pulmonary parenchymal disease: evaluation with high-resolution // Radiology- 1989. Vol.170:P.629–635.
4. Zwirewich C.V., Vedal S., Miller R.R., Miller N.L. Solitary pulmonary nodule: high-resolution CT and radiologic-pathologic correlation // Radiology:1991.-Vol. 179:P.469–476.
5. Beigelman-Aubry C., Hill C., Guibal A., Savatovsky J., Grenier P.A. Multi-detector row CT and postprocessing techniques in the assessment of diffuse lung disease // RadioGraphics- 2005.0Vol. 25:P.1639–1652.
7. Kiyomi Furuya, Kotaro Yasumori, Sadanori Takeo et al. Lung CT: Part 1, Mimickers of Lung Cancer–Spectrum of CT Findings With Pathologic Correlation

ТҰЖЫРЫМ

^{1,2}Ж.Ж. Жолдыбай, ^{1,2}Ж.К.Жакенова, ¹А.К. Кокталов, ¹Д.И. Сематов, ¹Ж.А. Калыев, ¹Г.С. Ахметова

¹Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты.

²С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ, Алматы қ.

Өкпе қатерлі ісігін ерте диагностикалаудағы компьютерлік томографияның мүмкіндіктері

Осы жұмыста өкпе қатерлі ісігін ерте диагностикалаудағы компьютерлік томографияның мүмкіндіктері баяндалған. Өкпе қатерлі ісігімен жалпы 3089 науқас зерттеліп, оның ішінде 190 науқас жынысы, жасы, процестің орналасуы бойынша талдау жасалынды. Өкпе қатерлі ісігінің қысқа сипаттамасы және сәулелі семиотикасы келтірілген. Зерттеу жұмысы көрнекі құралдармен бейнеленген.

Түйінді сөздер: компьютерлік томография, қатерлі ісік, өкпе.

SUMMARY

^{1,2} ZH.ZH. Zholdybay, ²Zh.K.Zhakenova, ¹A.K. Koktalov, ¹D.I. Sematov, ¹Zh.A. Kalyev, ¹G.C. Akhmetov

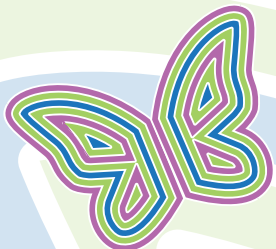
¹Kazakh Institute of Oncology and Radiology,

²KazNMU named after S.D. Asfendiyarov

Possibilities of the computer tomography in early diagnostics of lung cancer

In this article described possibilities of the computer tomography in early diagnostics of lung cancer. In total were examined the 3089th patients with diseases of lungs, from them the analysis is carried out to 190 patients on a sex, age, localization of process. The short characteristic and radial semiology of lung cancer is submitted. Article is followed by illustrative material.

Keywords: computer tomography, cancer, lungs.



**Созданный
в 2008 году
общественный фонд**

ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА

– это некоммерческая,
неправительственная благотворительная
организация, поддерживающая все
формы борьбы против рака.

МИССИЯ ФОНДА – в объединении усилий и потенциала
всего общества ради спасения тех, кого можно спасти, и
обеспечения достойной жизни тем, кого спасти нельзя.

ЦЕЛЬ – содействие развитию онкологической службы
Казахстана, включая деятельность, способствующую:

- эффективной профилактике
- ранней диагностике
- качественному лечению
- доступной паллиативной помощи

Общественный фонд «ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА»

Исполнительный директор: **Гульнара Кунирова**

Республика Казахстан, г. Алматы 050000, ул. Фурманова, 148-32

тел: +7 (727) 382-5950, факс: +7 (727) 382-61-49

e-mail: oncologykz@gmail.com, web: www.oncology.kz

Банковские реквизиты:

БИН: 080840016861

РНН: 600 900 611 530

ИИК: KZ419261802147889000 [KZT]

АО «Казкоммерцбанк»

БИК: KZKOKZKX

Для спонсорских переводов:

КНП-119, Кбе-18



ҚАТЕРЛІ ІСІКПЕН КҮРЕСЕЙІК
TOGETHER AGAINST CANCER
ВМЕСТЕ ПРОТИВ РАКА

ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫ • PUBLIC FUND • ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД

